

זיהוי ואבחנת דליריום בקבלהרפואית

תרשים זרימה מעשי לצוות סיעודי ורפואי - כלי עזר לאבחוןמהיר

סימנים אדומיםבקבלה

- בלבולחדש
- אי שקטפתאומי
- ישנוניותחריגה
- הזיות
- החמרה בערב("סאנדאונינג")

גורמים שכיחיםלחיפוש

MNEMONIC: DELIRIUM

- D** rugs (תרופות)
- E** lectrolytes (מטבוליזם) הפרעות
- L** ack of drugs / withdrawal
- I** nfection
- R** educed sensory input (ראייה/שמיעה)
- I** ntracranial
- U** rinary retention / constipation
- M** yocardial / metabolic

טיפ זהבלצוות

כל בלבול חריף = דליריום עדשהוכח אחרת

דמנציה, כרונית דליריום חריףותגודתי

קשב הוא המפתחלאבחנה

תרשים זרימה אלגוריתם(אבחוני

מטופל מתקבללמחלקה

האם יש שינויחריף במצב ההכרתיאו ההתנהגותי?

מידע / מהמשפחה / תיעוד התרשמות(צוות

אם
כן

בדיקת קשבוריוכו

:למשל(ספירת חודשים / אחורה(ספרות

האם יש פגיעה?בקשב

אם
כן

האם המצבתגודתי במהלך?היום

:למשל(מחמיר(בערב/לילה

אם
כן

הערכת חשיבה:ותודעה

- חשיבה לאמאורגנת
- / הזיות אישקט
- ירידהבערנות

אם:מתקיימים

- ✓ התחלה חריפה +תגודתיות
- ✓ פגיעהבקשב
- ✓ שינוי בחשיבה או במצבההכרה

חשד גבוהלדליריום

פעולות:מיידיות

1. דיווחלרופא
2. ביצועCAM
3. חיפוש גורמהפוך
4. התחלת מניעהוטיפול